

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 03

La Loi 08-22 : Le GST



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

INTRODUCTION

L'objectif de ce projet de loi est de faire face aux contraintes et obstacles qui entachent l'offre des soins au niveau territorial et de réformer le système national de santé dans son volet lié à la gouvernance, en se basant sur les choix stratégiques proposés dans le rapport général sur le nouveau modèle de développement, notamment la proposition relative au regroupement du centre hospitalier universitaire (CHU) et de l'ensemble des unités hospitalières régionales en un seul établissement public autonome chargé des soins hospitaliers, de la formation et de la recherche scientifique, et ce afin de réguler au mieux l'offre publique en termes de soins au niveau régional.

Le Groupement Sanitaire Territoriaux (GST), est un établissement constituant un nouveau modèle d'organisation sanitaire au Maroc. Ce nouveau modèle, remplacera les Directions Régionales de la Santé (DRS), est doté d'une **autonomie financière et administrative**. La GST regroupera tous les établissements de santé publics dans une région, tout en gardant la tutelle de l'Etat.

Ce projet comprend également des dispositions prévoyant la création d'un **groupement territorial de santé** dans chaque région, en se référant à un texte réglementaire pour déterminer le siège de chaque groupement et les institutions de santé qui le composent, et aussi pour définir les fonctions de chaque **groupement sanitaire territorial** au sein de son territoire, en répartissant les missions à chaque groupement selon **six domaines** fondamentaux à savoir : **l'offre de soins, la santé publique, les soins, la formation, celui de la recherche et de l'innovation**, ainsi que le domaine **administratif**, tout en déterminant les organes d'administration et de gestion représentés par **le conseil d'administration et le directeur général** du groupement et leurs attributions, en plus des dispositions qui déterminent la gestion financière des groupements de santé et leurs ressources humaines.

Le **GST** vise à :

- 🔗 Améliorer l'autonomie des hôpitaux afin de maximiser les décisions managériales contribuant à leur performance.
- 🔗 Créer une entité économique à part entière garantissant une meilleure performance des services de soins publics.
- 🔗 Refondre le modèle de financement et l'organisation des services de soins publics.
- 🔗 Consolider l'ancrage des hôpitaux dans l'écosystème politico-économique.

Les GST seront opérationnalisés selon différents **principes** :

- 🏠 Fusion des instances de prestation des soins,
- 🏠 Autonomie de gestion,
- 🏠 Autonomie de financement basée sur les assurances et un modèle hybride de facturation,
- 🏠 Création d'un établissement régional de santé autonome capitalisant sur le CHU,
- 🏠 Changement du statut du personnel et de leur rémunération.

CHAPITRE 1 : CRÉATION ET MISSIONS

🏠 **Le GST a pour l'objectif de MEP la politique de l'état en matière de santé**

🏠 **Etablissement public** comprend tous les établissements de santé publiques relevant de sa compétence territoriale **sauf** :

1. Les établissements de santé soumis à des dispositions législatives ou réglementaires particulières.
2. Établissements hospitaliers militaires. (FAR)
3. Les bureaux municipaux/communaux d'hygiène.

Etablissement public :

🏠 **Personnalité morale** : Personne juridique distincte. Peut Engager des contrats, poursuivre en justice, être poursuivi en justice et posséder des biens (etc....)

🏠 **Autonomie financière** : Capacité à gérer ses propres ressources financières de manière indépendante, sans dépendre directement du budget général de l'Etat. Chaque GST est soumis au contrôle financier de l'État, conforme à la législation en vigueur pour les établissements publics.

🏠 **Sous la tutelle de l'état** : Chaque GST est surveillé et orienté par l'état pour veiller au respect des règles énoncées dans la loi actuelle ainsi que celles énoncées dans la législation et la réglementation générales relatives aux établissements publics

L'objet de cette tutelle est d' :

- ❖ Assurer le respect de la loi 08-22 par les organes du GST
- ❖ Assurer le respect des missions du GST
- ❖ Assurer le respect des textes réglementaires organisant ce GST

L'objectif principal du GST est de régionaliser la santé marocaine pour assurer une meilleure coordination entre établissements, une meilleure gestion des ressources humaines et matérielles, un parcours de soins plus fluide, un renforcement de la santé publique.

LES 6 MISSIONS :

- 1. Offre de soins**
- 2. Soins**
- 3. Santé publique**
- 4. Formation**
- 5. Administration**
- 6. Recherche, expertise et innovation**

1. En matière d'offre de soins

- 1) L'élaboration et la mise à jour de la carte sanitaire régionale conformément aux orientations générales définies dans la carte sanitaire nationale.
- 2) La conception et la mise en œuvre d'un programme médical régional visant à renforcer l'offre de soins, en mettant l'accent sur les particularités de la région, en mutualisant les ressources disponibles et en garantissant la continuité des soins entre les différentes voies et niveaux de soins.
- 3) La création de nouveaux établissements de santé conformément à la carte sanitaire régionale.
- 4) L'organisation des parcours et la filière de soins de manière cohérente au sein des établissements de santé relevant de la région.
- 5) Assurer l'offre de soins au niveau régional conformément à la carte sanitaire régionale, coordonner les étapes de traitement et se baser sur le système d'information sanitaire national intégré tel qu'énoncé dans la loi cadre n° 06.22 précitée.
- 6) La mise en place d'un système d'information sanitaire régional pour la collecte, le traitement et l'utilisation des données de santé au niveau de la région, tout en respectant la législation relative à la protection des données à caractère personnel.

2. En matière de soins

- 1) Fournir des services de diagnostic, de traitement et de rééducation, que ce soit avec hébergement ou sans hébergement
- 2) Fournir des services de diagnostic et de traitement des maladies bucco-dentaires
- 3) Prendre en charge les patients, les blessés, les femmes enceintes et suivre leur état de santé
- 4) Prendre les mesures visant à garantir la sécurité des patients et la qualité de leur prise en charge

3. En matière de santé publique

- 1) Réaliser des activités visant à promouvoir et renforcer la santé, ainsi qu'à prévenir les risques sanitaires et à garantir la sécurité sanitaire, conformément aux programmes nationaux liés à la santé publique
- 2) Superviser la protection de la santé publique, assurer la surveillance sanitaire, et organiser la surveillance des épidémies
- 3) Assurer l'éducation sanitaire des bénéficiaires et encourager l'éducation thérapeutique
- 4) Organiser et superviser médicalement les services d'urgence hospitaliers
- 5) Participer à l'organisation et à la supervision médicale des services d'urgence préhospitaliers
- 6) Surveiller les épidémies émergentes

4. En matière de Formation

- 1) Assurer la formation pratique de base des étudiants en médecine, en pharmacie et en odontologie dans le secteur public, et si nécessaire, dans le secteur privé ;
- 2) Assurer la formation pratique de base des étudiants des établissements de formation publique dans les métiers infirmiers, sage-femmes, kinésithérapeutes, rééducateurs et rééducations fonctionnels, ainsi que les métiers des techniciens de la santé, et si nécessaire, dans le secteur privé :
- 3) Assurer la formation professionnelle des étudiants en formation dans les professions de la
- 4) Assurer la formation continue des professionnels de la santé, en collaboration avec les secteurs concernés et les organismes professionnels dans le domaine de la santé, ainsi que les associations pertinentes.

5. En matière d'Administration

- 1) Délivrer des licences pour exercer les professions ou activités suivantes dans le secteur privé, conformément aux procédures en vigueur : Sage-femme ; Métiers infirmiers ; Kinésithérapeutes, rééducateurs et ré adaptateurs fonctionnels ; Créer et exploiter des cliniques et des institutions similaires ;
- 2) Coordonner les activités des établissements de santé faisant partie du groupe ;
- 3) Veiller à la disponibilité des médicaments et des produits de santé au sein des établissements de santé faisant partie du groupe, en assurer la gestion et faciliter l'accès ;
- 4) Contribuer aux processus de surveillance et d'inspection financières, administratives et médicales des établissements de santé faisant partie du groupe ;
- 5) Évaluer les performances des établissements de santé faisant partie du groupe ;
- 6) Encourager la collaboration avec tous les acteurs dans le domaine de la santé au niveau de la région, en particulier les administrations publiques, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile ;
- 7) Coordonner, dans le cadre d'accords de partenariat, entre les établissements de santé faisant partie du groupe et les établissements de santé relevant du secteur privé.

6. En matière de Recherche, expertise et innovation

- 1) Contribuer à la recherche scientifique dans le domaine de la santé en collaboration avec les établissements de recherche en santé ;
- 2) Participer aux travaux de recherche dans le domaine de la santé publique, de l'économie de la santé et de la gestion de la santé ;
- 3) Réaliser des expertises médicales légales, biomédicales et techniques ;
- 4) Contribuer à l'évaluation des technologies médicales ;
- 5) Établir des pôles d'excellence et des centres de référence au sein des établissements de santé qui relèvent de sa compétence ;
- 6) Développer la technologie médicale ;
- 7) Exploiter chaque brevet dans le domaine de la santé conformément aux dispositions légales en vigueur.

CHAPITRE 2 : Direction et gestion Articles

GST est : **Dirigé** par un **conseil administratif** CA et **Géré** par un **directeur général**

1. Les Membres du conseil administratif (CA)

- 1) Président : chef du gouvernement + (secrétariat : directeur générale)
- 2) Les représentants des administrations concerner définies par le texte réglementaire :
 - ❖ Un représentant du Premier Ministre
 - ❖ Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée des finances ;
 - ❖ Un représentant de l'autorité gouvernementale en charge de la santé
 - ❖ Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de la formation professionnelle ;
 - ❖ Un représentant de l'autorité gouvernementale chargée de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
 - ❖ Un représentant de l'Inspection du Service de Santé Militaire des Forces Armées Royales
- 3) Le président de conseil régional ou son représentant.
- 4) Le WALI de la région ou son représentant
- 5) Le doyen de La FMPMD relevant de l'Enseignement Supérieur public présent au niveau de la région ou leur représentant :
 - ❖ Trois représentants des enseignants-chercheurs en médecine, pharmacie et dentisterie, élus selon les conditions et modalités précisées par décision conjointe des deux autorités gouvernementales responsables.
- 6) Les représentants des enseignants chercheurs dans la FMPMD exerçant dans les établissements de santé composant le Groupement :
 - ❖ Trois représentants du reste des professionnels de santé, dont un représentant du corps des médecins, dentistes et pharmaciens, et deux représentants du corps des infirmiers et techniciens de santé, élus selon les conditions et modalités précisées par décision de l'autorité gouvernementale en charge de la santé.
- 7) Le directeur de l'ISPITS au niveau de la région ou leur représentant
- 8) Un (1) représentant de chaque organisme responsable de la gestion de l'AMO
- 9) Un représentant du conseil régional de l'ordre national des médecins
- 10) Les représentants des professionnels de santé exerçant dans les établissements de santé composant le groupement

- 11) Trois membres indépendants ayant l'expertise dans le domaine de la santé
- 12) A titre consultatif, le président peut inviter toute personne jugée utile.

2. Les attributions du conseil administratif

Le CA jouit de tous les pouvoirs et attributions nécessaires pour l'administration du Groupement.

Il exerce, spécialement, les 16 attributions suivantes :

- 1) Valider le plan d'action d'annuel du GST ;
- 2) Approuver la carte sanitaire régionale conformément aux orientations de la carte sanitaire nationale ;
- 3) Approuver le PMR ;
- 4) La délibération au tour de la gestion des établissements de santé constituant le GST et la prise de toutes les dispositions nécessaires pour améliorer les services de ces établissements ;
- 5) Arrêter le budget du Groupement et des plans prévisionnels pluriannuels ainsi que les méthodes de financement de ses programmes d'activités ;
- 6) Arrêter les comptes annuels du groupement, leur validation et la prise de décision par rapport aux résultats ;
- 7) Approuver l'organigramme qui définit les structures du groupement et leurs spécialités y compris une structure sanitaire, une structure administrative et financière indépendantes.
- 8) Approuver le statut des professionnels de santé du groupe conformément au modèle de statut des professionnels de santé des groupements territoriaux de santé, qui est déterminé par un texte réglementaire.
- 9) L'approbation du règlement selon lequel sont définies les conditions et les formes de passation des marchés ;
- 10) L'approbation du règlement intérieur du Groupement ;
- 11) La prise de décisions relatives à l'acquisition, location et cession de biens immobiliers
- 12) La prise de décisions quant à l'acquisition de brevets ou inventions relatives aux activités du Groupement, de son exploitation ou de sa cession ;
- 13) La prise des décisions relatives aux contributions dans les capitaux d'entreprises privées selon des textes législatifs et réglementaires en vigueur à condition que la principale mission de l'entreprise soit en rapport avec les missions du Groupement ;

14) La prise de toutes les dispositions pour l'exécution des missions d'audits et d'évaluation périodiques des activités du GST ;

15) L'approbation du rapport annuel d'activités du GST ;

16) La concertation autour de toute question ayant trait aux missions du Groupement.

- ❖ CA peut donner une dérogation au directeur général pour régler des affaires spécifiques
- ❖ CA se réunit sur convocation de son président chaque fois que le nécessite s'en fait sentir, au moins **2 fois/an en vue de :**
- ❖ Dresser le bilan des réalisations et surveiller l'exécution de ses décisions, ainsi que dresser les bilans financiers de l'année qui précède.
- ❖ Etablir le programme prévisionnel et budget de l'exercice financier.

3. Le directeur général

Le DG peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions aux agents sous son autorité.

Le DG du groupe bénéficie de tous les pouvoirs et compétences nécessaires pour gérer le groupe et agit en son nom

4. Les attributions DG :

Exécuter les décisions du Conseil d'administration et, le cas échéant, les décisions d'un comité créé par ce dernier.

- 1) Exécuter les décisions du Conseil d'Administration et, le cas échéant, les décisions des comités qu'il crée ;
- 2) Préparer les projets soumis au Conseil d'Administration pour approbation ou adoption, notamment :
 - ❖ Le plan de travail annuel du groupe
 - ❖ La carte sanitaire régionale
 - ❖ Le programme médical régional
 - ❖ Le budget annuel du groupe
 - ❖ La structure organisationnelle
 - ❖ Le statut particulier du personnel
 - ❖ Le système régissant les conditions et les formes de conclusion des contrats

- ❖ Le règlement interne du groupe ;
 - ❖ Le rapport annuel d'activité du groupe ;
- 3) Gérer toutes les composantes du groupe et les établissements de santé qui en font partie, ainsi que coordonner leurs activités ;
 - 4) Gérer les ressources humaines du groupe, procéder aux nominations conformément à la structure organisationnelle du groupe et au système de base de ses utilisateurs ;
 - 5) Réaliser toute action ou activité liée aux missions du groupe ou donner l'autorisation de le faire ;
 - 6) Représenter le groupe devant l'État, les administrations publiques ou privées, ainsi que devant les tiers, et prendre toutes les mesures conservatoires ;
 - 7) Représenter le groupe devant les tribunaux, intenter toute action en justice visant à défendre les intérêts du groupe et en informer immédiatement le président du Conseil d'Administration.
 - 8) Le Directeur Général peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et compétences aux employés relevant de son autorité.

CHAPITRE 3 : L'organisation financière

1. Le budget du groupement

1) Rubrique ressource :

- ❖ Revenus générés par ses activités
- ❖ Revenus des fonds mobiliers et immobiliers
- ❖ Subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autorité soumise à la loi publique ou privée
- ❖ Les dons et legs
- ❖ Toute autre ressource selon les textes réglementaires et juridiques en vigueur.

2) Rubrique dépenses :

- ❖ Dépenses d'investissement
- ❖ Dépenses de fonctionnement
- ❖ Remboursement des avances et des emprunts
- ❖ Toute autre dépense en relation avec les missions du groupement

CHAPITRE 4 : LES PROFESSIONNELS DE SANTE

1. Professionnels de santé du GST :

- 👤 Professionnels de la santé recrutés conformément aux dispositions statutaires du groupe
- 👤 Fonctionnaires et agents transférés au groupe conformément aux dispositions statutaires du groupe
- 👤 Fonctionnaires détachés auprès du groupe conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
- 👤 Des experts engagés pour accomplir des tâches spécifiques pendant une durée déterminée.
- 👤 Contractuels ou de volontaires

2. Les Modalités de Transfer :

Les modalités de transfert des fonctionnaires et agents contractuels travaillant dans les services de santé déconcentrés ou les CHU :

- 👤 Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents contractuels des services déconcentrés et des CHU situés sur le territoire d'un groupement, seront transférés dans le groupement concerné.
- 👤 Ces professionnels de santé transférés seront intégrés selon le statut du groupement.
- 👤 Ils continueront de bénéficier de leur cadre d'origine à partir de la date du transfert et conserveront leurs droits et prérogatives existants.
- 👤 Leurs prestations effectuées avant le transfert seront reconnues comme étant réalisées dans le groupement.
- 👤 Ils resteront affiliés aux caisses de retraite auxquelles ils cotisaient avant le transfert.

CHAPITRE 5 : Dispositions finales et transitoires

1. Dispositions finales et transitoires :

- 👤 Les nouveaux groupements prennent en charge les contrats et engagements des CHU et services décentralisés de l'État.
- 👤 Les biens mobiliers, immobiliers, archives, et dossiers sont transférés gratuitement aux groupements concernés.

🔗 Le terme “GST” remplace les termes “administration” et “autorité gouvernementale compétente”.

Loi relative	Numero	Dahir N*	Date de promulgation	N* DU BO	Date de publication	Lieu	N* Chapitre/article
Groupement territoriaux sanitaire	08.22	1.23.50	28.06.2023		17.07.2023	TETEOUN	5 CHAPITRES 23 ARTICLES

Organigramme du GST :

Le GST est composé de trois grandes branches fonctionnelles et organisationnelles :

🔗 **Le Pôle de Gouvernance Générale**, qui comprend :

1. Le Directeur Général

2. Les Directions, Division et services transversaux :

- ✓ Direction Stratégie et Santé Publique ;
- ✓ Direction Recherche Formation et Innovation ;
- ✓ Direction des Systèmes information
- ✓ Division Audit, Qualité et Contrôle de Gestion ;
- ✓ Service Communication
- ✓ Service Appui à l’inspection et au Contrôle des établissements.

🔗 **La Branche Administrative**, en charge du soutien et du fonctionnement institutionnel du GST, comprend en plus du Directeur Général adjoint de la branche administrative les directions suivantes :

- ✓ La Direction du Capital Humain,
- ✓ La Direction des Affaires Financières,
- ✓ La Direction des Achats, de l’Approvisionnement et de la Logistique,
- ✓ La Direction du Patrimoine, de l’Ingénierie et de la Maintenance.

☁ **La Branche Sanitaire**, comprend en plus du Directeur Général adjoint de la branche sanitaire les établissements de santé suivants :

- ✓ **Les établissements hospitaliers universitaires (niveau tertiaire)**
- ✓ **Les espaces sanitaires et districts sanitaires** (niveau secondaire), organisés par sous-territoire
- ✓ **Les Établissements de Soins de Santé Primaires (ESSP), Établissements Médico-Sociaux (EMS) et structures spécialisées d'appui** (niveau primaire).

Il est institué auprès du Directeur Général du Groupement Sanitaire, un comité consultatif et de suivi et des comités médicot techniques, le cas échéant.

1. Le comité consultatif et de suivi : Un Comité Consultatif et de Suivi est composé des Directeurs des Organes de direction, des établissements Hospitaliers Universitaires et des espaces sanitaires. Le Directeur Général peut adjoindre à ce comité tout cadre du Groupement dont il juge la présence utile.

Le Comité se réunit sur convocation du Directeur Général, chaque fois que de besoin, et au moins, une fois par mois ; il est consulté sur des questions concernant l'organisation et le fonctionnement de l'ensemble des établissements en général et émet des avis et des recommandations notamment sur les points suivants :

- ☁ Le projet des établissements, le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et les programmes d'investissements relatifs aux travaux et équipements et matériels lourds ;
- ☁ Le budget, le rapport annuel d'orientation budgétaire, les critères de répartition de ressources, les comptes ainsi que le tableau des emplois ;
- ☁ Les créations, suppressions, transformations des structures médicales et non médicales ;
- ☁ Les modalités de constitution des Centres de responsabilité ;
- ☁ Les conditions et l'organisation du travail au sein du groupement, notamment les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leurs incidences sur la situation du personnel ;

- ☞ Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par des dispositions législatives ou réglementaires ;
- ☞ La politique générale de formation du personnel et notamment le plan de formation, le bilan social et les modalités d'une politique d'intéressement ;
- ☞ Les actions de coopération

2. Les comités médicaux-techniques : En cas de besoin, le Directeur Général du Groupement peut constituer des comités médicotéchniques composés de responsables ou de toute personne qualifiée dans les différents domaines en relation avec l'organisation, le fonctionnement et la mission du GST.

Les 5 Valeurs :

1. Innovation

L'innovation doit être promue dans nos actions afin de trouver de meilleures options pour l'amélioration du service rendu au patient et sa famille et à l'étudiant. Cette innovation devra concerner toutes les activités y compris les modes de gestion. Elle doit être orientée vers les bénéfices à la population servie.

2. Intégrité

Valeur de référence, nous devons en permanence faire preuve de transparence et d'intégrité à tous les niveaux afin de conquérir la confiance des patients, de leurs familles et des citoyens en général.

3. Éthique

Les pratiques aussi bien de soins que de recherche et d'enseignements sont porteurs de risques éthiques. Ce risque doit en permanence être évalué et toutes les approches doivent respecter les principes qui régissent l'éthique médicale.

4. Engagement

Rien de grand ne pourra être atteint si nous ne sommes pas tous engagés pour notre réussite collective. Dans un contexte caractérisé par la pression de la population et la rareté des ressources, les défis ne peuvent être relevés sans un, alignement et une contribution collective pour l'atteinte des objectifs communs.

5. Qualité

Ce que nous entendons par la qualité est celle des pratiques de soins, de la relation aux patients et à l'étudiant ainsi que celle de la relation entre les professionnels de notre institution. Nous travaillerons ensemble pour accréditer et certifier nos structures et nos pratiques selon les meilleurs standards.